

## BRADIARRITMIAS BENIGNAS

*Paula Menéndez Suárez, Julio César Echarte Morales, Javier Borrego Rodríguez, Miguel Rodríguez Santamarta*

Las bradiarritmias son los ritmos cardíacos con frecuencias inferiores a 60 latidos por minuto (lpm). Son un proceso clínico frecuente y comprenden diversos trastornos del ritmo, algunos benignos (sin riesgo de muerte súbita, la indicación de estimulación será fundamentalmente para control de síntomas), entre los que destacan las diferentes formas de **disfunción del nódulo sinusal** y el **síndrome del seno carotídeo**, en los que se centrará el capítulo. Por otra parte están los **bloqueos aurículo-ventriculares**, que se tratan en el capítulo correspondiente.

Pueden ser hallazgos electrocardiográficos casuales, estando el paciente asintomático, o por el contrario provocar un amplio espectro de síntomas (disnea, mareo, pre-síncope o síncope, síntomas inespecíficos...), los cuales pueden ser permanentes o intermitentes. Pueden ser de causa extrínseca (típicamente fármacos), intrínseca (alteraciones en el sistema de conducción) o, a veces, pueden ser una respuesta fisiológica normal ante determinadas circunstancias. Para su diagnóstico es fundamental una correcta correlación entre los síntomas y el ritmo cardíaco y, por lo general, se establece con pruebas diagnósticas no invasivas (historia clínica, electrocardiograma de 12 derivaciones, Holter, prueba de esfuerzo). Excepcionalmente se necesitan pruebas electrofisiológicas invasivas. Una vez descartadas las posibles causas reversibles de las bradiarritmias, como los fármacos (generalmente bloqueantes del nodo aurículo-ventricular como betabloqueantes, antagonistas del calcio no hidropiridínicos, digoxina...), o enfermedades subyacentes tratables, el marcapasos cardíaco suele ser el tratamiento de elección para las bradiarritmias sintomáticas. En tratamiento farmacológico de las bradiarritmias suele limitarse al momento agudo, pues a largo plazo no ha demostrado mejoría de los síntomas o de la supervivencia.

### DISFUNCIÓN DEL NODO SINUSAL (DNS) O SÍNDROME DEL SENO ENFERMO

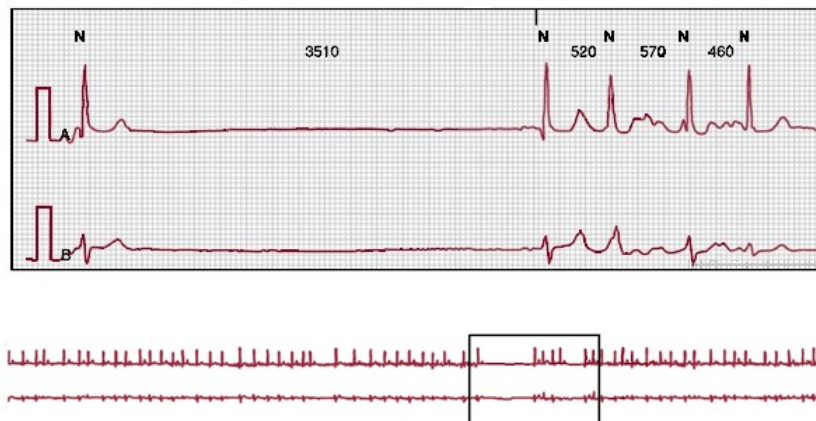
Se considera disfunción sinusal a una alteración en la función de marcapasos del nodo sinusal. En la actualidad, es la segunda causa más frecuente de implante de marcapasos definitivo en nuestro medio tras el bloqueo aurículo-ventricular.

En general, la DNS es un trastorno crónico y progresivo, que se produce principalmente en ancianos. Incluye alteraciones tanto en forma de taquiarritmia como de bradiarritmia. Dentro de estas últimas:

- **Bradicardia sinusal:** frecuencia sinusal menor de 60 lpm. En la mayoría de los casos, suele ser una reacción fisiológica y no un estado patológico. Se observa en deportistas entrenados y en adultos jóvenes sanos en reposo y por la noche (incluso menor de 30 lpm durante la noche). En los pacientes con bradicardia sinusal persistente, sobre todo < 40 lpm durante el día y síntomas de bradicardia, la bradicardia sinusal es patológica y a menudo manifestación de una DNS.
- **Pausas sinusales:** puede producirse por un problema de generación del impulso en el nodo sinusal o por un fallo de la conducción del impulso a la aurícula. Se considera que las pausas de 3 o más segundos justifican la implantación de un marcapasos en los pacientes sintomáticos.
- **Ritmo nodal:** ritmo regular, con frecuencia entre 40-60 lpm y característicamente sin ondas P visibles (aunque pueden aparecer dentro del QRS o retrógradas), con QRS generalmente estrecho. Si el paciente presenta antecedentes de fibrilación auricular, probablemente se trate

de una fibrilación auricular bloqueada (son ECG indistinguibles).

- **Síndrome de bradicardia-taquicardia típico:** taquiarritmias (típicamente fibrilación auricular) que terminan de forma súbita y se siguen de una pausa hasta el primer latido sinusal, debido a un tiempo de recuperación prolongado del nodo sinusal. Importante: Puede precisar tratamiento antitrombótico si cumple criterios de anticoagulación de la fibrilación auricular.



Para su diagnóstico es fundamental establecer una correlación entre síntomas y ritmo cardíaco, pues es frecuente la clínica de mareo de otros orígenes, especialmente en la población anciana. Normalmente es suficiente con pruebas no invasivas (ya mencionadas previamente).

El tratamiento debe limitarse a aquellos pacientes en los que se ha documentado una clara correlación entre síntomas y ritmo. En caso de que sean asintomáticos no requieren un tratamiento específico. Lo primero es descartar o tratar las causas extrínsecas reversibles de DNS y la bradicardia sinusal fisiológica.

### SÍNDROME DE HIPERSENSIBILIDAD DEL SENO CAROTÍDEO

Ante estímulos “normales” (afeitarse, ponerse la corbata, mover el cuello...) del seno carotídeo, se produce una actividad desmesurada de impulso vagal, que produce bradicardia y/o hipotensión.

Se diagnostica comprimiendo manualmente el seno carotídeo, el cual puede generar una respuesta cardioinhibitoria (predomina la disminución de la frecuencia cardíaca), vasopresora (predomina la disminución de la tensión arterial) o mixta. La maniobra es positiva si las pausas son mayores de 3 segundos o si el descenso de la TA sistólica es más de 50 mm Hg junto con síntomas del paciente.

El tratamiento es evitar maniobras estimulantes. Si el paciente se encuentra muy sintomático o tiene una respuesta fundamentalmente cardioinhibidora, puede valorarse el implante de marcapasos.

### BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR.

Ver capítulo correspondiente.

### FIBRILACIÓN AURICULAR (FA) BLOQUEADA.

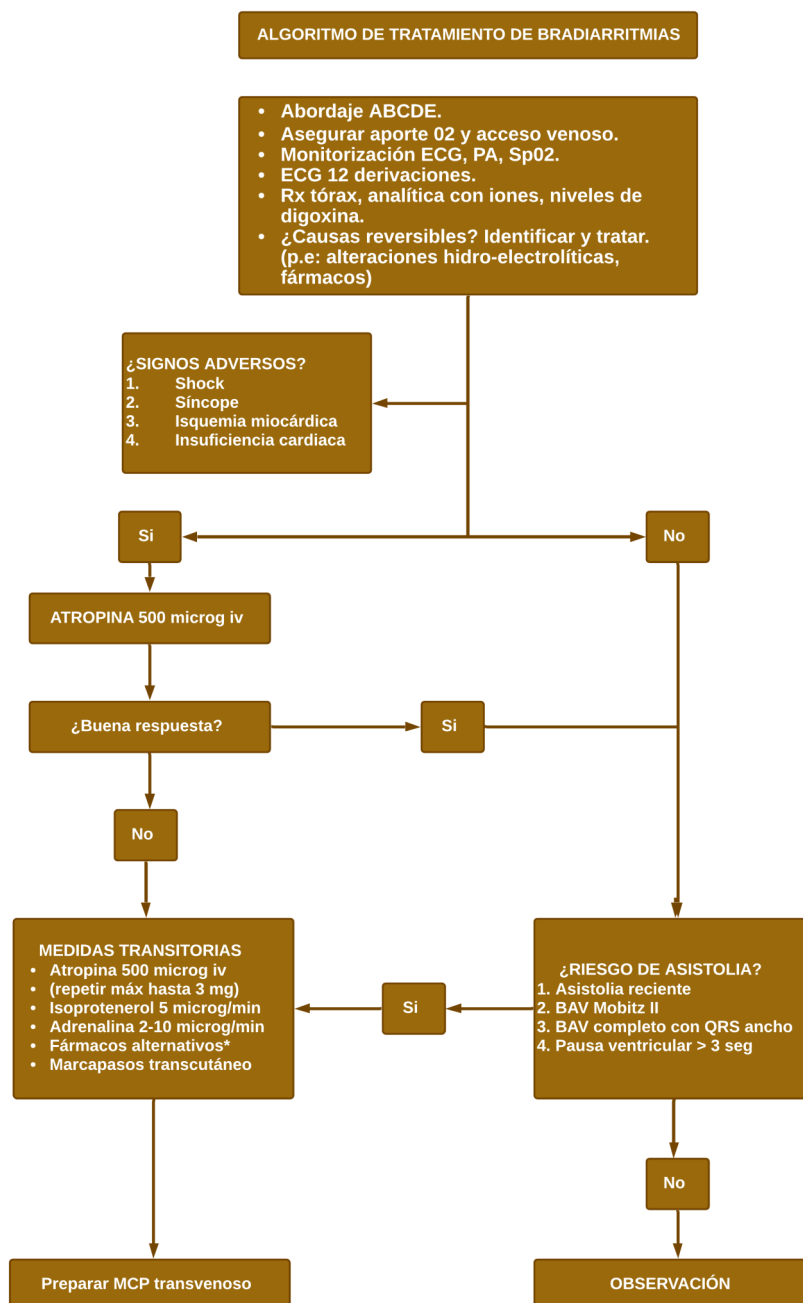
La FA bloqueada es la única FA rítmica.

Paciente que acude con ritmos regulares sin ondas “p” a baja frecuencia o paciente con antecedentes de FA que se presenta con una bradicardia rítmica, nos obliga a realizar un estudio etiológico:

- Reversión espontánea a ritmo sinusal: se ha descrito hasta en un 70% de los pacientes con FA de menos de 72 horas de evolución pero es muy poco frecuente en FA crónicas.
- Intoxicación digitálica: la causa más frecuente de intoxicación digitálica es la hipopotasemia, y como causas favorecedoras fundamentales la insuficiencia renal y la edad avanzada.
- Alteración de la conducción: bloqueo completo del nodo AV que bradicardice la frecuencia apareciendo un ritmo nodal.

### **FA CON RESPUESTA VENTRICULAR MEDIA LENTA NO ES LO MISMO QUE FA BLOQUEADA.**

- Una FA lenta continúa siendo un ritmo irregular, pero con una frecuencia cardíaca menor de 60 lpm Valorar según síntomas.
- Una FA bloqueada se convierte en un ritmo regular y con una frecuencia cardíaca menor de 40 lpm Llamar a Cardiología.



### Actuación en urgencias

- Dieta absoluta
- Monitorización de constantes vitales, ECG y pulsioximetría.
- VTM/ O<sub>2</sub> endonasal 2 LX'endonasales según estado clínico del paciente.
- Vía periférica
- Telemetría
- Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, ProBNP (si disnea/edemas), PCR, troponina US, CKmb. Coagulación básica: D-Dímero si disnea brusca. Sistemático y sedimento de orina (si fiebre). Gasometría arterial si SatO<sub>2</sub> menor a 94%.
- ECG de 12 derivaciones con tira de ritmo.
- Rx tórax postero anterior y lateral, en caso inestabilidad Rx a pie de cama del paciente.

**BIBLIOGRAFÍA**

- Vogler J, Breithardt G, Eckardt L . Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. Rev Esp Cardiol. 2012;65(7): 656-667.
- <http://www.revespcardiol.org/es/bradiarritmias-bloqueos-conduccion/articulo/90141414/>